

TEMA 3.3 • UROLOGÍA

Vejiga Neurogénica

PERFIL EUNACOM 1.08.1.009

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **vejiga neurogénica** se define como la disfunción del tracto urinario inferior secundaria a una lesión o enfermedad del sistema nervioso. En términos simples, es una vejiga que ha quedado **denervada**, lo que impide su contracción normal y eficiente para el vaciamiento, derivando en cuadros de retención crónica e incontinencia.

Es fundamental no confundir esta patología con la **uropatía obstructiva baja** (como la hiperplasia prostática) ni con otros tipos de incontinencia, ya que su fisiopatología y, sobre todo, su manejo son radicalmente distintos.

Etiología y Causas Principales

La vejiga neurogénica no es una enfermedad primaria, sino la manifestación de una patología neurológica subyacente. Las causas más frecuentes incluyen:

- **Lesiones de la médula espinal:** Es la causa clásica. Se observa en pacientes con antecedentes de traumatismo raquímedular (TRM) o enfermedades desmielinizantes como la **Esclerosis Múltiple**.
- **Polineuropatías severas:** Especialmente la neuropatía autonómica en pacientes con **Diabetes Mellitus tipo 2** de larga data y mal control metabólico.
- **Mielodisplasias:** Como el espina bífida en pacientes pediátricos.
- **Cirugías pélvicas mayores:** Que pueden dañar el plexo hipogástrico.

Clínica y Presentación

El cuadro clínico suele estar precedido por el antecedente de la lesión neurológica. Los síntomas son a menudo inespecíficos pero sugerentes de una falla en el vaciamiento:

- **Polaquiuria:** Aumento de la frecuencia miccional, pero con volúmenes pequeños.
- **Incontinencia urinaria por rebalse:** La vejiga se llena hasta su máxima capacidad y el exceso "escurre" sin control.
- **Infecciones urinarias recurrentes:** El residuo post-miccional actúa como caldo de cultivo para bacterias, facilitando **Infección del Tracto Urinario** a repetición.
- **Urgencia miccional con vaciamiento incompleto:** El paciente siente un deseo intenso de orinar, pero al intentarlo, no es capaz de contraer el detrusor de forma efectiva.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: Al perder la innervación motora, el músculo detrusor entra en una fase de **atonía o hipotonía**. A diferencia de la vejiga de lucha en la obstrucción, aquí no hay hipertrofia, sino una tendencia a la atrofia de las paredes vesicales por desuso y sobredistensión crónica.

Diagnóstico

El diagnóstico es fundamentalmente **clínico**, basándose en la historia del paciente (ej. paciente que tras un accidente de tránsito presenta dificultad miccional). Sin embargo, para confirmar y caracterizar el tipo de disfunción se utilizan:

- **Urodinamia:** Es el "gold standard". Permite observar la ausencia de contracciones del detrusor durante la fase de vaciamiento (vejiga arreflexia).
- **Ecografía renal y vesical:** Útil para medir el **residuo post-miccional** (que suele ser muy elevado) y evaluar el estado de las paredes de la vejiga.
- **Imágenes complementarias:** Para descartar daño renal secundario (hidronefrosis) por reflujo vesicoureteral.

Diagnóstico Diferencial

Es vital diferenciar la vejiga neurogénica de la uropatía obstructiva:

TABLA 3.3.1: CARACTERÍSTICA VS VEJIGA NEUROGÉNICA

CARACTERÍSTICA	VEJIGA NEUROGÉNICA	UROPATÍA OBSTRUCTIVA BAJA
Pared del Detrusor	Fina, atrófica	Hipertrófica ("Vejiga de lucha")
Contracciones	Ausentes (Areflexia)	Presentes o inestables
Residuo Post-miccional	Muy aumentado	Aumentado
Causa	Neurológica (Ej. Esclerosis Múltiple)	Mecánica (Ej. Hiperplasia Prostática Benigna)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, si te describen una vejiga con paredes finas y gran residuo post-miccional en un paciente con trauma o diabetes, marca **Vejiga Neurogénica**. Si las paredes están engrosadas y hay síntomas obstructivos, piensa en **Uropatía Obstructiva**.

Tratamiento y Manejo

El objetivo principal del tratamiento es proteger la función renal (evitar el reflujo y las infecciones) y mejorar la calidad de vida del paciente.

Autocaterismo Limpio Intermitente (ALI)

Es la piedra angular del tratamiento. - **Técnica:** El paciente (o sus padres en caso de niños) introduce una **Sonda Nélaton** varias veces al día (habitualmente cada 4-6 horas) para vaciar la vejiga y luego la retira. - **Concepto "Limpio":** No requiere técnica estéril de pabellón; basta con el lavado de manos y una técnica higiénica. Esto reduce drásticamente el riesgo de infecciones comparado con las sondas permanentes.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

No confundir: El uso de una **Sonda Foley** (permanente y estéril) debe evitarse a largo plazo en estos pacientes debido al altísimo riesgo de infecciones urinarias, formación de cálculos y riesgo de cáncer de vejiga por irritación crónica. El ALI es la opción de elección.

Otras medidas:

- **Tratamiento de la causa de base:** Manejo de la **Diabetes Mellitus tipo 2** o rehabilitación del trauma raquímedular. - **Rehabilitación de piso pélvico:** En casos seleccionados con remanentes de función. - **Fármacos:** En algunos casos se usan colinérgicos (para estimular contracción) o anticolinérgicos (si hay hiperreflexia del detrusor asociada), pero el ALI sigue siendo lo más importante.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: El tratamiento de elección de la vejiga neurogénica es el **Autocaterismo Limpio Intermitente (ALI)**. Recuerda que es "Limpio" (no estéril) e "Intermitente" (no permanente).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente de treinta y ocho años con antecedente de traumatismo raquímedular hace dos años. Desde entonces presenta polaquiuria, pérdida involuntaria de orina en pequeñas cantidades e infecciones urinarias recurrentes. Al momento de ir al baño refiere urgencia intensa pero no logra vaciar bien la vejiga. La ecografía muestra vejiga con paredes finas y residuo postmiccional de doscientos mililitros. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Vejiga Neurogénica. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La vejiga neurogénica es causada por denervación vesical, más frecuentemente por lesión medular en esclerosis múltiple o traumatismo raquímedular, o por polineuropatía diabética severa
- La clínica incluye incontinencia urinaria por rebose, infecciones urinarias recurrentes, polaquiuria con volúmenes pequeños, y urgencia miccional paradójica sin capacidad de vaciar la vejiga
- En la urodinamia el detrusor de la vejiga neurogénica no tiene contracciones, a diferencia de la vejiga inestable de la uropatía obstructiva que presenta contracciones no inhibidas
- Las paredes del detrusor están finas o atróficas en la vejiga neurogénica, en contraste con el detrusor hipertrófico de la vejiga de lucha de la uropatía obstructiva baja
- El residuo postmiccional elevado es el hallazgo que comparte la vejiga neurogénica con la uropatía obstructiva baja, siendo el elemento más orientador al diagnóstico
- El tratamiento más importante de la vejiga neurogénica es el autocateterismo limpio intermitente con sonda nelaton, que es limpio pero no estéril, e intermitente pero no permanente
- El cateterismo con sonda Foley es estéril y permanente, a diferencia del cateterismo limpio intermitente con nelaton que se usa en la vejiga neurogénica

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (VEJIGA NEUROGÉNICA)**PREGUNTA 1**

Paciente de treinta y ocho años con antecedente de traumatismo raquímedular hace dos años. Desde entonces presenta polaquiuria, pérdida involuntaria de orina en pequeñas cantidades e infecciones urinarias recurrentes. Al momento de ir al baño refiere urgencia intensa pero no logra vaciar bien la vejiga. La ecografía muestra vejiga con paredes finas y residuo postmiccional de doscientos mililitros. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Uropatía obstructiva baja por hiperplasia prostática benigna
- B)** Vejiga neurogénica por lesión medular
- C)** Incontinencia de urgencia por vejiga inestable
- D)** Estenosis uretral post-traumática
- E)** Infección urinaria recurrente como causa primaria

PREGUNTA 2

Paciente de cuarenta y cinco años con esclerosis múltiple de larga data que desarrolla vejiga neurogénica confirmada por urodinamia. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para el manejo de la función vesical?

- A)** Instalar sonda Foley permanente para manejo definitivo del vaciamiento vesical
- B)** Autocateterismo limpio intermitente con sonda nelaton
- C)** Tamsulosina para mejorar el vaciamiento vesical
- D)** Realizar cistostomía suprapúbica como primera línea de tratamiento
- E)** Oxibutinina para estimular las contracciones del detrusor

PREGUNTA 3

En la evaluación urodinámica de un paciente con vejiga neurogénica versus un paciente con incontinencia de urgencia por vejiga inestable, ¿cuál es el hallazgo diferenciador más importante?

- A)** El residuo postmiccional elevado está presente solo en la vejiga neurogénica
- B)** Las contracciones no inhibidas del detrusor están presentes en la vejiga inestable y ausentes en la vejiga neurogénica
- C)** Las paredes del detrusor hipertróficas se ven solo en la vejiga neurogénica
- D)** La polaquiuria está presente solo en la incontinencia de urgencia
- E)** El antecedente de lesión neurológica descarta completamente la vejiga inestable

RESUMEN: VEJIGA NEUROGÉNICA

La vejiga neurogénica es la pérdida de la función vesical normal por denervación, lo que impide que la vejiga se contraiga adecuadamente. Las causas más frecuentes son las lesiones medulares, como las producidas en contexto de esclerosis múltiple o traumatismo raquímedular, y las polineuropatías severas como la neuropatía diabética avanzada. Clínicamente se manifiesta con antecedente de la causa de base, polaquiuria, incontinencia urinaria por rebose, infecciones urinarias recurrentes por vaciamiento incompleto, y urgencia miccional paradójica en la que el paciente siente urgencia pero no puede evacuar la vejiga por falta de contracción. El diagnóstico es fundamentalmente clínico cuando el antecedente es claro, como un traumatismo raquímedular. Cuando hay dudas diagnósticas se confirma con urodinamia y estudios de imagen. Los hallazgos imagenológicos de la vejiga neurogénica son distintos a los de la uropatía obstructiva baja, lo que permite diferenciarlas. En la vejiga neurogénica el detrusor tiene paredes finas por atrofia, a diferencia del detrusor hipertrófico de la vejiga de lucha en la uropatía obstructiva. El residuo postmiccional está muy aumentado en ambas condiciones, pero en la urodinamia la vejiga neurogénica muestra ausencia de contracciones del detrusor, mientras que en la vejiga inestable de la uropatía obstructiva hay contracciones no inhibidas. Esta diferencia es fundamental para el diagnóstico diferencial. El tratamiento de la vejiga neurogénica es el autocateterismo limpio intermitente, que es la medida más importante y diferenciadora de esta patología. Es importante destacar que se realiza con sonda nelaton, que es un cateterismo limpio pero no estéril, y es intermitente, no permanente, a diferencia del cateterismo con sonda Foley que es estéril y permanente. En niños lo realizan los padres. Se complementa con el tratamiento de la causa de base cuando es tratable y con rehabilitación cuando corresponde.